KBV KASSENÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG

WEITERENTWICKLUNG AMBULANTES OPERIEREN – AKTUELLER SACHSTAND DER VERHANDLUNGEN

50. DEUTSCHER KOLOPROKTOLOGEN-KONGRESS MÜNCHEN AM 16. MÄRZ 2024



ANNA MARIA RASKOP
ABTEILUNGSLEITERIN MEDIZINISCHE DOKUMENTATION

Intern

Vortrag: Weiterentwicklung Ambulantes Operieren: Aktueller Stand der Verhandlungen

AutorIn: Anna Maria Raskop, Berlin [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: BeraterIn (B):	**Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung der Autorin / des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)**
[2]: EigentümerIn (E):	**Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)**
[3]: InvestorIn (I):	**Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, AnteilseignerIn etc.)**
[4]: MitarbeiterIn (M):	**Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (MitarbeiterIn des Produktherstellers)**
[5]: Produkt (P):	**Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)**
[6]: Keine (K):	**Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form**

- ↗ HYBRID-DRG-VERORDNUNG
- ↗ ABRECHNUNGSVEREINBARUNG
- ↗ ERWEITERUNG LEISTUNGSKATALOG
- ↗ WEITERE AKTIVITÄTEN AMBULANTES OPERIEREN



↗ HYBRID-DRG-VERORDNUNG
↗ ABRECHNUNGSVEREINBARUNG
↗ ERWEITERUNG LEISTUNGSKATALOG
↗ WEITERE AKTIVITÄTEN AMBULANTES OPERIEREN



Verordnung zu einer speziellen sektorengleichen Vergütung

➢ Rechtsgrundlage: § 115f SGB V

Abs. 1:

Vertragsparteien nach § 115f SGB V (GKV-Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Kassenärztliche Bundesvereinigung) vereinbaren eine spezielle sektorengleiche Vergütung (für ambulanten und stationären Fall) und den Leistungskatalog bis zum **31. März 2023**.

Abs. 4:

Verordnungsermächtigung: BMG übernimmt die Aufgaben, soweit eine dreiseitige Vereinbarung ganz oder teilweise nicht oder nicht fristgerecht zustande gekommen ist.

Verordnung zu einer speziellen sektorengleichen Vergütung

- Hybrid-DRG-Verordnung nach § 115f SGB V
  - Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 21. Dezember 2023
  - Inkrafttreten 1. Januar 2024 und Außerkrafttreten 31. Dezember 2024
  - Sogenannter „Startkatalog“ umfasst fünf Leistungsbereiche, 244 OPS-Kodes, die nach 12 Fallpauschalen (Hybrid-DRG) abgerechnet werden
  - Regelungen zum Abrechnungsverfahren aus rechtlichen Gründen nicht enthalten

    ⇨ BMG verweist auf die Aufgabe der Selbstverwaltung, Abrechnungsverfahren für die Hybrid-DRG gangbar zu machen

- Anpassung § 115f SGB V vom 16.12.2023
  - Eine Vereinbarung über die Erweiterung des Leistungskatalogs ab dem Jahr 2025 ist zum 31.03.2024 vorgesehen!

- ↗ HYBRID-DRG-VERORDNUNG
- ↗ **ABRECHNUNGSVEREINBARUNG**
- ↗ ERWEITERUNG LEISTUNGSKATALOG
- ↗ WEITERE AKTIVITÄTEN AMBULANTES OPERIEREN



Abrechnungsvereinbarung

- Abrechnungsmodalitäten zwischen KBV und GKV-Spitzenverband getroffen
  - Rückwirkendes Inkrafttreten zum 1. Januar 2024
  - Einleitung Unterschriftsverfahren am 1. März 2024

- Verfahren ab 1. Januar 2025
  - Neuer Datensatz für die Hybrid-DRG-Abrechnung mit allen grouperrelevanten Informationen
  - Gilt für Direktabrechner, KVen und dritte Abrechnungsdienstleister
  - Abrechnung täglich möglich
  - Zahlungsfrist der Krankenkassen: 21 Tage

Abrechnungsvereinbarung – Übergangsregelung

Warum?

- Technik für das neue Abrechnungsverfahren ist von Krankenkassen einzurichten
  - Frist zur technischen Umsetzung bis Ende 2024

Bis dahin:

- Abrechnung über Pseudo-Gebührenordnungspositionen in Quartalsabrechnung mit der KV
  - Pseudo-GOP stehen mit dem Update für das 2. Quartal in der Praxisverwaltungssoftware bereit

Voraussetzung:

- Anwendung einer Grouper-Software zur Ermittlung, ob ein Eingriff einer Hybrid-DRG zugewiesen werden kann
  - Eingaben Minimalanforderung: Alter, OPS-Kodes (Anlage 1 Hybrid-DRG-Verordnung) und ICD-10-Kode der Haupt- und Nebendiagnosen

Übergangsregelung – Abrechnung konkretes Vorgehen

Haben Sie einen Eingriff aus einem der fünf Leistungsbereiche der Hybrid-DRG-Verordnung vorgenommen, prüfen Sie, ob es dafür eine Hybrid-DRG gibt.

Schritt 1:

- Geben Sie dazu in die Grouper-Software die geforderten Daten ein – neben den OPS-Kodes (aus Anlage 1 der Hybrid-DRG-Verordnung) unter anderem die ICD-10-Kodes der Haupt- und Nebendiagnosen, die Einfluss auf den Eingriff haben
  - Hierbei sind die Deutschen Kodierrichtlinien anzuwenden
  - Löst der Grouper eine Fallpauschale aus, kann der Eingriff mit der Hybrid-DRG abgerechnet werden, anderenfalls erfolgt eine Abrechnung nach EBM

Übergangsregelung – Abrechnung konkretes Vorgehen

Für einen Eingriff aus einem der fünf Leistungsbereiche wurde eine der Hybrid-DRG ermittelt

Schritt 2:

- Für jede Hybrid-DRG gibt es eine Pseudo-GOP
  - Diese GOP geben Sie in Ihrer Abrechnung an
  - Zusätzlich kennzeichnen Sie die Hauptdiagnose, die den Eingriff begründet hat
  - Nähere Hinweise zur Kennzeichnung erhalten Sie von Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung

➢ **https://www.kbv.de/html/1150_68194.php**



Abrechnung Hybrid-DRG

- Abrechnungsvorgaben Hybrid-DRG
  - Eingriff nur von einem am Eingriff beteiligten Arzt abzurechnen
  - Fallpauschale nur einmal berechnungsfähig

    ⇨ umfasst alle Untersuchungen und Behandlungen, inkl. Sachkosten, die im unmittelbaren Kontext der OP durchgeführt wurden!

- Abrechnungsmöglichkeit EBM
  - Nach Auskunft des BMG ergibt sich ein Abrechnungsausschluss laut § 115f SGB V „nicht eindeutig“

    ⇨ Wahlmöglichkeit der Abrechnung nach Hybrid-DRG-Verordnung oder nach EBM grundsätzlich möglich – jedoch klare Positionierung des GKV-SV: Kassen bezahlen Eingriffe nach EBM nicht !

EBM-Anpassungen im Zusammenhang mit Hybrid-DRG

➢ Präoperative Abklärung und postoperative Behandlung sind nicht Bestandteil der Hybrid-DRG

› Beratungen für eine Übergangsreglung zwischen KBV und GKV-Spitzenverband aufgenommen
  › Öffnung der EBM-Gebührenordnungspositionen aus dem Abschnitt 31.1 Präoperative Abklärung und 31.4 Postoperative Behandlung
    - Rückwirkendes Inkrafttreten zum 1. Januar 2024
    - Befristung bis 31. Dezember 2024

- ↗ HYBRID-DRG-VERORDNUNG
- ↗ ABRECHNUNGSVEREINBARUNG
- ↗ **ERWEITERUNG LEISTUNGSKATALOG**
- ↗ WEITERE AKTIVITÄTEN AMBULANTES OPERIEREN



Katalogerweiterung – Priorisierung zum 1. April 2024

➢ Ziel: Dreiseitige Vereinbarung um eine erneute Rechtsverordnung zu verhindern!

- Dreiseitiger Konsens:
  - Weiterentwicklung zunächst bei bestehenden Rahmenbedingungen der Rechtsverordnung
  - Umfang der Erweiterung analog zur Rechtsverordnung mit einem Fallzahlvolumen von 200.000 stationären Behandlungen mit einem Belegungstag

- Ansatz KBV:
  - Erweiterung um OPS-Kodes/DRG mit geringen Sachkosten
  - Überwiegende Auswahl von Eingriffen/DRG gemäß Anlage 3
  - Betrachtung von DRG mit einem Anteil von fallzahlstarken Verfahren

Katalogerweiterung – Priorisierung zum 1. April 2024

- Dreiseitige Voten Sachstand 6. März 2024
  - Aufnahme von ca. 100 weiteren Eingriffen aus sechs Leistungsbereichen
  - Fallzahlvolumen 300.000 groupierungsrelevante Fälle gemäß IGES-Gutachten 2019 mit einer Liegezeit von bis zu drei Tagen!
  - endgültige Fallzahl für Hybrid-DRG nicht genau abschätzbar jedoch eher deutlich niedriger

- Neue Leistungsbereiche
  - Endoskopische Eingriffe an Galle, Leber, Pankreas
  - Proktologische Eingriffe an Analfisteln
  - Brusterhaltende Eingriffe der Mammachirurgie
  - Osteosynthetische Versorgung von Klavikulafrakturen

- Erweiterung von Leistungsbereichen der bestehenden Rechtsverordnung
  - Hernienchirurgie
  - Operationen am Sinus Pilonidales

Katalogerweiterung – Priorisierung zum 1. April 2024

➢ Regelungsumfang bis zum 1. April 2024

- Aufnahme der neuen OPS-Kodes mit dreiseitigem Beschluss in die Anlage 1 der Rechtsverordnung
  - Festlegung der OPS-Kodes zur Ansteuerung der Hybrid-DRG
- Vorgaben von Rahmenbedingungen der Kalkulation
  - u. a. Liegedauer, Ausschlusskriterien, Sachkostenüberprüfung
- Formaler Beschluss mit definiertem Vorgehen zur Erweiterung des Kataloges inkl. Hybrid-DRG-Zuordnung zum 1. Januar 2025
- Übergabe der Kodes an die Institute, insbesondere InEK, zur Ermittlung der Hybrid-DRG mit entsprechender Bewertung unter Einbeziehung der Auftraggeber DKG, GKV-SV und KBV
  - Abschließende Festlegung und Beschlussfassung bis Oktober 2024

Katalogerweiterung – Priorisierung zum 1. April 2024

➢ Regelungsumfang bis zum 1. April 2024

› Juristische Ersteinschätzung
  › Es ist nicht davon auszugehen, dass das BMG von der Möglichkeit einer Ersatzvornahme Gebrauch macht, wenn sich die dreiseitigen Vertragspartner bereits auf eine Erweiterung des Leistungskatalogs geeinigt haben und die Bewertungen nach dem 1. April 2024 durch die dreiseitigen Vertragspartner festgelegt werden.

↗ HYBRID-DRG-VERORDNUNG

↗ ABRECHNUNGSVEREINBARUNG

↗ ERWEITERUNG LEISTUNGSKATALOG

↗ WEITERE AKTIVITÄTEN AMBULANTES OPERIEREN



Weitere Aktivitäten ambulantes Operieren

- Ausblick § 115b SGB V - dreiseitig
  - Beratungen sollen im 2. Quartal wieder aufgenommen werden
  - Stand jetzt – keine größeren Katalogerweiterungen geplant

- Weiterentwicklung Anpassung EBM Kapitel 31 - zweiseitig
  - Erweiterung der Verfahren und der Dauer einer verlängerten Nachbeobachtung
  - Aufnahme einer Vergütungsregelung für ein erweitertes Schmerzmanagement

VIELEN DANK!


ELF 6
Der Patientenservice
116117
Die Nummer mit den Elfen
ELF 7